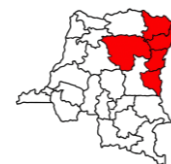




TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°107/MVEBDB/29/08/2026

Date de rapportage : 29 août 2026

Date de publication : 30 août 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

Pour la journée du 29 août 2026, 96 nouveaux cas confirmés dont 41 décès communautaires de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été enregistrés dans les provinces de l'Ituri (61 cas), du Nord-Kivu (28 cas), Haut Uélé (7). De plus, 8 décès intra-CTE ont été enregistrés.

Aucune nouvelle zone de santé touchée au cours de dernières 24h.

CUMUL DES CAS 6 041	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS 2 911	LETALITE 48,2%	PATIENS EN ISOLEMENT/CTE 619	CUMUL DES GUÉRIS 1 366	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour) 82,4 %
--	--	-------------------------------------	---	---	---



Provinces touchées et Zones de santé touchées



6 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



60 Zones de santé touchées sur 151

(39,7%)



Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures

Au total, **96 nouveaux cas confirmés** dont **41 décès communautaires** de la Maladie à Virus Ebola (MVE) ont été rapportés au cours des dernières 24h, dans les provinces de l'Ituri (**61 cas**), **Nord-Kivu (28)**, **Haut Uélé (7)**.

Fort et heureusement, **39 patients** ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE (34 en Ituri et 5 au Haut Uele). En revanche, **8 décès intra-CTE** ont été enregistrés, dont 7 en Ituri et 1 au Haut Uélé. Ce qui porte **le nombre des décès du jour à 49**.

Depuis le début de l'épidémie jusqu'au 29 août 2026, **6 041 cas confirmés** dont **2 911 décès** ont été rapportés en RDC, soit une létalité de **48,2 %**. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant **82,3 %** des cas confirmés cumulés et **63,5 %** des nouveaux cas rapportés.

Globalement, 60 des 151 (39,7%) zones de santé des six provinces restent affectées depuis le début de l'épidémie en RDC. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (15/34) du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) et Bas Uélé (3/11).

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 29 août 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	61	4972	2 247	45,2%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	28	828	559	67,5%	15/34 (44,1 %)
Haut-Uélé	7	216	94	43,5%	6/13 (46,1 %)
Tshopo	0	19	8	42,1%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas Uélé	0	3	2	66,7%	3/11(27,3%)
Total	96	6 041	2 911	48,2%	60/151 (39,7 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone de santé, au 29 août 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	4972	2247	45,2%	61	28	7	35
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	158	35	22,2%	1	0		0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1392	437	31,4%	17	7		7
Damas	28	9	32,1%	1	0		0
Drodro	13	6	46,2%				0
Fataki	74	30	40,5%				0
Gethy	6	2	33,3%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	32	12	37,5%				0
Komanda	74	48	64,9%	2	0		0
Lita	218	119	54,6%	8	8		8
Logo	11	5	45,5%				0
Lolwa	19	4	21,1%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	17	7	41,2%				0
Mandima	36	21	58,3%				0
Mangala	236	122	51,7%	9	5		5
Mongbwalu	609	285	46,8%	1	0		0
Nia-Nia	214	113	52,8%	9	5		5
Nizi	652	260	39,9%	6	2		2
Nyankunde	124	35	28,2%				0
Rimba	10	4	40,0%				0

Rwampara	945	337	35,7%	6	1		1
Tchomia	57	25	43,9%	1	0		0
A ventiler**	NA	314	NA	NA	NA	7	7
Nord-Kivu	828	559	67,5%	28	13	0	13
Beni	136	98	72,1%	8	5		5
Biena	1	1	100,0%				0
Butembo	164	124	75,6%	4	3		3
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	16	7	43,8%				0
Katwa	389	256	65,8%	12	3		3
Kyondo	16	12	75,0%				0
Lubero	1	1	100,0%				0
Mabalako	3	2	66,7%				0
Manguredjipa	1	0	0,0%				0
Masereka	8	4	50,0%				0
Musienene	78	45	57,7%	3	2		2
Mutwanga	1	1	100,0%				0
Oicha	7	6	85,7%				0
Vuhovi	6	2	33,3%	1	0		0
Haut-Uélé	216	94	43,5%	7	0	1	1
Boma Mangbetu	27	14	51,9%	1	0		0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	81	33	40,7%	2	0		0
Pawa	28	16	57,1%	4	0		0
Rungu	1	0	0,0%				0
Wamba	76	30	39,5%			1	1
Tshopo	19	8	42,1%	0	0	0	0
Bafwasende	2	0	0,0%				0
Kabondo	3	1	33,3%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	9	4	44,4%				0
Mangobo	2	2	100,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	3	2	66,7%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	1	0	0,0%				0
Ganga	1	1	100,0%				0
Total	6041	2911	48,2%	96	41	8	49

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province et sont en cours de ventilation pour être classifié par zone de santé.

NA : Non Applicable.

** Ces décès ont été enregistrés dans les différents CTE de la province de l'Ituri et sont en cours de ventilation.

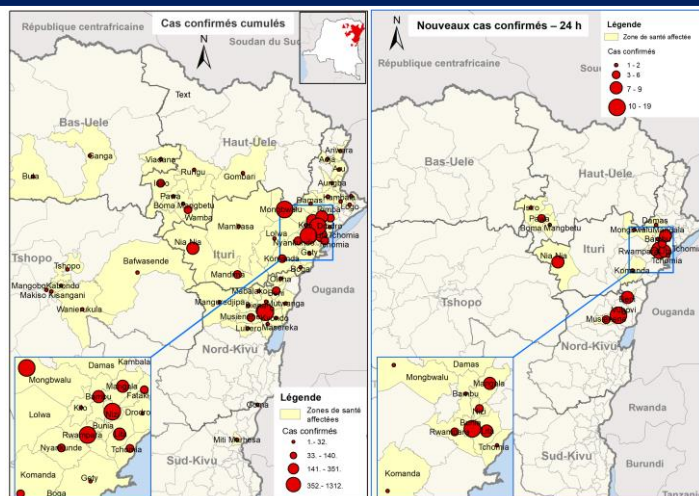
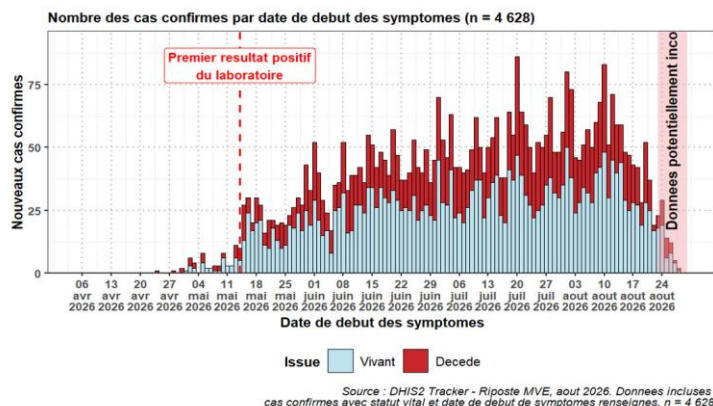
Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province, au 29 août 2026

DPS	Nouvelles Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	17	2	19	12	2	0	0	14	12
Bas Uélé	13	1	14	1	1	12	0	2	0
Ituri	680	40	720	106	33	325	6	139	90
Nord-Kivu	899	52	951	105	52	637	0	157	77
Sud-Kivu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tshopo	126	0	126	8	0	116	0	8	2
Total Général	1735	95	1 830	232	88	1090	6	320	181

ND : Non disponible.

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours

Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24h et cumulés) par zone de santé.



1. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

1.1.Coordination

1.1.1. Principales Actions

- Suivi et accompagnement des actions de la réponse dans toutes les provinces touchées.

1.1.2. Surveillance épidémiologique

1.1.3. Principales Actions

Au terme de la journée du 29 août 2026, 1 830 alertes ont été enregistrées dans les 5 parmi les 6 actuellement touchées, dont 1 416 (77,4%) ont été vérifiées. Les 320 cas suspects validés ont tous été investigués (100 %) et 181 d'entre eux ont été transférés vers les CT/CTE (Tableau 3).

Au cours des dernières 24 heures, la proportion des contacts suivis se situe à 82,4 % (18 520 vus sur 22 463 à suivre), en dessous du seuil de 85 % : Ituri 86,8 % (9 770/11 270), Tshopo 44% (200/455), Nord-Kivu 83,6 % (7 525/8 996), Haut Uélé 57,4% (830/1 445) et Bas Uélé 62,6% (186/297).

1.1.4. Défis

Persistance d'un faible suivi des contacts autour des cas confirmés dans les provinces du Bas et Haut Uélé, lié à une insuffisance des équipes dédiées à ces activités.

1.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

1.2.1. Principales actions

- Huit (8) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours des dernières 24 heures : cinq au Nord-Kivu, dont deux validées au PoC Mukulia (ZS Beni) et référées au centre de transit et trois invalidées après investigation ; une au Haut-Uélé, au PoC Magambe (ZS Isiro), validée mais la personne concernée a refusé son transfert vers le CT ; deux au Bas-Uélé, aux PoC PK65 Sukisa et PK25 Koteli (ZS Koteli), toutes deux invalidées après investigation.

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoC/PoE par province, en date du 29 août 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Tshopo	Haut-Uélé	Bas-Uélé	Global
Complétude des rapports	95 % (57/60)	100 % (18/18)	55,5 % (5/9)	71,4 % (5/7)	64 % (7/11)	45 % (9/20)	80,8 % (101/125)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	9,09 % (1/11)	100 %	NA	35 % (7/20)	64 % (7/11)	ND	ND
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	146 033	85 571	8 267	6 691	13 719	4 412	264 693
% des voyageurs screenés	97,5 %	97,0 %	98,0 %	99,0 %	99,0 %	98,9 %	97,5 %
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,3 %	97,0 %	98,0 %	99,0 %	98,0 %	98,9 %	97,3 %
% des voyageurs sensibilisés	99,5 %	97,0 %	100 %	98,0 %	98,0 %	98,9 %	98,6 %
Nombre d'alertes notifiées	0	5	0	0	1	2	8
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	0	2	0	0	1	0	3
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0	0	0	0
% des cas suspects transférés au CT/CTE	NA (0/0)	100 % (2/2)	NA	NA	0 % (0/1)	NA	66,7 % (2/3)
% des corps sans vie swabés/sécurisés	NA (0/0)	NA (0/0)	NA	NA	NA (0/0)	NA	NA (0/0)
% des cas suspects investigués dans 24 h	NA (0/0)	100 % (2/2)	NA	NA	100 % (1/1)	100 % (2/2)	100 % (5/5)

1.2.2. Défis

Opérationnalisation des PoE/PoC non optimale et complétude de rapportage insuffisante (101 rapports sur 125 : 80,8 %), avec des niveaux faibles au Bas-Uélé (45 %), au Sud-Kivu (55,5 %), au Haut-Uélé (64 %) et à la Tshopo (71,4 %). En Ituri, 1 (9,09 %) des 11 PoE/PoC stratégiques fonctionne sans interruption et les PoC d'Avakubi, Mabakese et Apinaka n'ont pas rapporté. À la Tshopo, 7 PoC sont activés sur les 20 planifiés (35 %).

1.3. Laboratoire

1.3.1. Principales actions

- Ituri : 61 nouveaux résultats positifs** (33 vivants et 28 décès) sur 342 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 17,8 %**).
- Tshopo** : 6 nouveaux échantillons ont été reçus, tous sont revenus négatifs.

- **Nord-Kivu : 28 nouveaux résultats positifs** (15 vivants et 13 décès) sur 157 échantillons analysés (**positivité de 17,8%**).
- **Haut-Uélé : 7 nouveaux résultats positifs** (7 vivants) sur 31 échantillons analysés (**positivité : 22,6%**).
- **Bas-Uélé : 1 échantillon reçu et testé**, le résultat est revenu négatif.

1.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

1.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 33 rings ont été ouverts sur les 45 identifiés (73,3 %), 117 ménages décontaminés sur 144 identifiés (81,3 %) et 13 FOSA sur 14 (92,9 %) ; 30 kits d'hygiène ont été dotés aux ménages à Mongwalu et 4 évaluations de FOSA ont été réalisées.
- **À la Tshopo**, réalisation du suivi et accompagnement de 11 ESS dans 5 ZS (Makiso-Kisangani, Mangobo, Tshopo, Kabondo et Lubunga) au cours desquels 119 prestataires ont été briefés sur la mise en œuvre des mesures PCI.
- **Au Haut-Uélé**, clôture de la formation en PCI de base de 50 prestataires de la ZS de Pawa ; 2 rings ouverts sur 5 et 6 ménages décontaminés sur 20 à Wamba.

1.4.2. Défis

- Faible mise en œuvre des normes de PCI : en Ituri, l'ouverture des rings non optimale (73,3 %) et la décontamination des ménages à 81,3 % de réalisation ; insuffisance d'équipes de décontamination à Fataki, Mangala et Nizi et manque de mobilité à Komanda, Bambu, Mandima et Mangala. Au Nord-Kivu, seuls 4 rings ont été ouverts et 9 ménages décontaminés sur 17 identifiés (52,9 %).
- À la Tshopo, insuffisance d'EPI dans les ESS, prestataires non formés et panne de l'incinérateur de l'HGR Makiso-Kisangani.

1.5. Continuité des soins

1.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 117 nouvelles admissions ont été enregistrées et 119 sorties dont 34 guéris. Ainsi, 550 patients sont hospitalisés pour 978 lits, soit un taux d'occupation de 56,2 %.
- **Au Haut Uélé**, 12 nouvelles admissions de cas suspects ont été enregistrées et 9 sorties dont 5 guéris ; 44 patients sont hospitalisés pour 120 lits, soit un taux d'occupation de 36,7 %.
- **À la Tshopo**, 1 nouvelle admission a été enregistrée contre 4 sorties et 10 patients sont en isolement pour 25 lits, soit un taux d'occupation global de 40,0%.
- **Au Sud-Kivu**, 15 cas suspects restent suivis en hospitalisation.

1.5.2. Défis

Faible capacité d'accueil et absence de CTE dans certaines zones de santé : au Haut-Uélé aux CTE d'Isiro et de Wamba ; en Ituri, les CTE de Bambu et de Nizi sont saturés ; au Bas-Uélé, absence de CTE aux normes et de partenaire d'appui à la prise en charge.

1.6. Communication sur les risques et engagement communautaire

1.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 185 personnes ont été touchées autour des derniers cas confirmés (89 à Nia-Nia/Alimasi, 37 à Lolwa/Mabangifo, 26 à Rwampara, 19 à Lolwa et 14 à Kilo/Itendey) ; 78 enfants sensibilisés lors d'une séance de masse à Nia-Nia en prélude à la rentrée scolaire ; 1 ring ouvert et 7 EDS facilitées à Rwampara ; 137 contacts listés à Rwampara, 68 à Nia-Nia et 37 à Kilo avec l'appui de la CREC.

- **À la Tshopo**, sensibilisation de 477 personnes (175 femmes, 140 hommes et 162 enfants) auprès des déplacés internes de Konga-Konga et Simisimi avec l'appui de l'ONGD GOVA ; briefing de 64 SUPRO en prélude à la campagne de vaccination ; 3 émissions radiodiffusées et diffusion de spots (RNTC, Eben Ezer et Canal Orient) ; 1 rumeur clarifiée.
- **Au Nord-Kivu**, sensibilisation des Wazalendo à l'adhésion aux activités de riposte et sécurisation de 3 PoC (Mususa, Cugeki et Kyaghala).
- **Au Haut-Uélé**, 1 082 personnes touchées par des sensibilisations de masse et 77 causeries éducatives ; dialogues communautaires à Pawa (252 personnes) et à Isiro, 41 visites à domicile et élaboration d'une stratégie de communication avec les leaders d'opinion et les chauffeurs de taxi-moto ; au Bas-Uélé, sensibilisation en langues locales à la radio RTF Likati et redynamisation des CODESA des AS Lobi et Mboli.

1.6.2. Défis

Persistance des défis au niveau communautaire : au Haut-Uélé, refus de prélèvement par trois PPL et 3 évasions à Isiro.

1.7. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

1.7.1. Principales actions

- **En Ituri**, 19 personnes ont bénéficié d'interventions SMSPS autour des derniers cas confirmés (Bunia 8, Rwampara 5, Nizi 3, Lita 2 et Komanda 1).
- **Au Nord-Kivu**, 25 des 55 nouveaux cas confirmés et suspects ont bénéficié d'interventions SMSPS ; 86 annonces de résultats sur 102 ont été réalisées dont 25 positives, 62 ménages accompagnés, 98 PPL soutenus, 5 enfants suivis en communauté, 2 guéris réinsérés sur 4 (50 %) ; les 4 ZS ayant notifié sont couvertes (100 %).
- **Au Haut-Uélé**, accompagnement psychologique d'une famille endeuillée à Neisu (ZS Isiro) ; 15 résultats de laboratoire annoncés (11 à Isiro et 4 à Pawa) dont 4 positifs ; 46 accompagnants et 21 PPL appuyés.

1.7.2. Défis

- **Au Haut Uélé**, couverture SMSPS insuffisante. **Au Nord-Kivu**, seules 4 ZS sont couvertes par des interventions autour des derniers cas et les crèches font défaut dans les CTE. **En Ituri**, aucune couverture à Bambu, Nia-Nia, Mambasa et Lolwa, la couverture reste limitée à 5 des 11 ZS ayant notifié (45 %).

1.8. Logistique

1.8.1. Principales actions

Dans la Tshopo, réception d'un kit informatique pour la gestion des données (financement US CDC/IRT) ; déploiement d'un kit Starlink à Bafwasende et de blouses aux équipes de vaccination ; suivi de la construction des sites d'isolement (Madula, Kabondo et Konga-Konga) ainsi que du CTE de grande capacité

Au Nord-Kivu, approvisionnement de la ZS de Mabalako en médicaments ; poursuite des travaux d'érection du CTE de Matanda et colisage des intrants nutritionnels pour Biena et Manguredjipa. Au Haut-Uélé, reprise des travaux d'installation du CTE d'Isiro et livraison d'intrants PCI/EDS à la ZS de Rungu.

1.9. Sécurité

1.9.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, couverture sécuritaire des équipes PCI dans les AS de Butsili, Madrandele et Kanzunzulili ainsi qu'au CS Nyakunde ; accompagnement de l'équipe EDS au cimetière de Bundji pour l'enterrement de 4 corps de cas confirmés et pour des swabs au CH Peregrin et au CH Don Divin ; supervision et évaluation sécuritaire au PoE Kyaghala et au PoC Kitakandi.

1.9.2. Défis

La sécurisation des PoC stratégiques reste incomplète : au Haut-Uélé, le corps sans vie intercepté au PoC de Magambe (ZS Isiro) a été relâché par la sécurité sans avoir pu être swabé. Au Nord-Kivu, l'insécurité persiste dans les zones d'enterrement et la route menant au cimetière de Bundji (ZS de Beni) reste impraticable.

1.10. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

1.10.1. Principales actions.

En Ituri, poursuite de la sensibilisation à la PSEAH des acteurs de la riposte et des communautés ; affichage des messages et de la distribution de dépliants dans les ZS de Bunia, Aru, Rwampara et Mongbwalu ; à la Tshopo, intégration des messages PSEAH dans les séances de sensibilisation des PPL des établissements de soins de Makiso-Kisangani.

1.10.2. Défis

- Couverture encore insuffisante des activités PSEA : 25 % des zones de santé de l'Ituri (9/36) connaissent le mécanisme de signalement et seuls 2 partenaires (OMS et IMC) rapportent leurs activités PSEA ; absence de cartographie des intervenants ; insuffisance de supports de sensibilisation de masse ; manque de moyens de transport et d'équipement informatique pour le pilier.

MESSAGES CLES

- La transmission continue de la MVE, avec 96 nouveaux cas dont 41 décès communautaires et 8 intra- CTE enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le cumul national à 6 041 cas confirmés et 2 911 décès.
- L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 82,3 % des cas confirmés cumulés et 63,5% des nouveaux cas rapportés au cours des dernières 24 heures et une expansion plus importante (28 des 36 ZS affectées).
- La surveillance affiche une bonne performance (100%) des cas suspects investigués tandis que le taux de suivi (82,4%) en dessous du seuil de 85,0%.
- Le renforcement des interventions prioritaires (surveillance, prise en charge, PCI, logistique et engagement communautaire) demeure essentiel pour interrompre rapidement les chaînes de transmission.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr Kombe NGWAMA John

Equipe rédaction

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard

Dr Katusi Biselenge Jules

Madame Mayele Afua Marie

Dr Diur Mananashi Floryan

Mr Kamuina Kebela John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd